



Pr N TACHFOUTI, MD, MPH, PhD

Questions

- Comment faire diminuer la gravité de la pandémie Covid 19 ?
 - Dans le monde, au Maroc
- Comment faire diminuer la mortalité maternelle ?
 - Dans le monde, au Maroc
- Comment faire baisser la prévalence du diabète ?

Questions

- Comment prendre en charge tous les malades atteints de cancer au Maroc ?
- Comment prendre en charge tous les malades atteints d'hépatites C au Maroc ?
- Est-il possible de vacciner toute la population ?

Questions

- Le nombre d'hôpitaux, est-il suffisant ?
- Le nombre de médecins, est-il suffisant ?
- Le nombre de personnels paramédical est-il suffisant ?
- Comment améliorer la motivation de la RH ?

Questions

- Le budget du MS, est-il suffisant ?
- L'assurance maladie ?
- La recherche médicale est-elle développée ?
- L'industrie pharmaceutique ,
- Le prix du médicament ?
- Le conseil de l'ordre.

Situations liées aux systèmes de santé

Problématique

- Les urgences du CHU de Fès reçoivent trop de patients comparativement aux autres hôpitaux de la ville

- Pourquoi ?



Un enfant de deux ans a de la fièvre et des convulsions. Sa mère le conduit à l'hôpital le plus proche, distant de 30 kilomètres



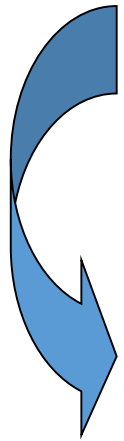
on lui annonce que le stock de médicaments nécessaires pour traiter l'infection est épuisé.

Un ouvrier doit être opéré. Pour payer l'intervention, qui lui sauvera la vie, la famille dépense toutes ses économies,



se retrouve alors dans l'impossibilité de régler le loyer et perd son logement.

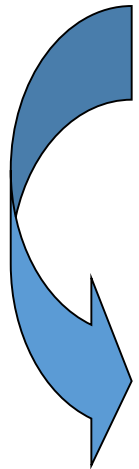
Une infirmière, surmenée du fait des mauvaises conditions de travail et du manque d'effectifs dans l'hôpital où elle travaillait et incapable de subvenir aux besoins des nombreuses personnes à sa charge,



émigre pour trouver un emploi mieux rémunéré.

Une femme accouche après trois jours d'attente, seule sa belle-sœur est à ses côtés. L'enfant est mort-né et la mère garde de graves séquelles – une fistule obstétricale

Un adolescent a la main écrasée lors d'un accident. Son père le conduit au centre de santé le plus proche mais tous les deux en repartent désespérés après avoir attendu six heures dans une salle d'attente avant de voir le réceptionniste, qui s'est mis en colère lorsque le père a demandé des antalgiques pour soulager les souffrances de son fils. Le père et le fils sont rentrés chez eux et ont pansé la plaie du mieux qu'ils ont pu.



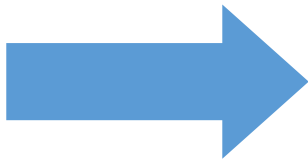
Le garçon a presque totalement perdu l'usage de sa main.

De tels drames se produisent tous les jours, surtout dans les pays pauvres.

 mauvais fonctionnement du système de santé.

Quand :

- **une mère reçoit un courrier lui rappelant que son jeune fils doit être vacciné contre une maladie mortelle,**
- **une famille a finalement accès à de l'eau propre dans son village grâce à une pompe bien entretenue parce que les pouvoirs publics ont parrainé un projet d'assainissement**
- **un patient atteint de VIH/SIDA bénéficie, pour un coût abordable, d'antirétroviraux, de conseils nutritionnels et d'examens réguliers dans le même dispensaire,**
-



le système de santé fonctionne correctement.

En résumé

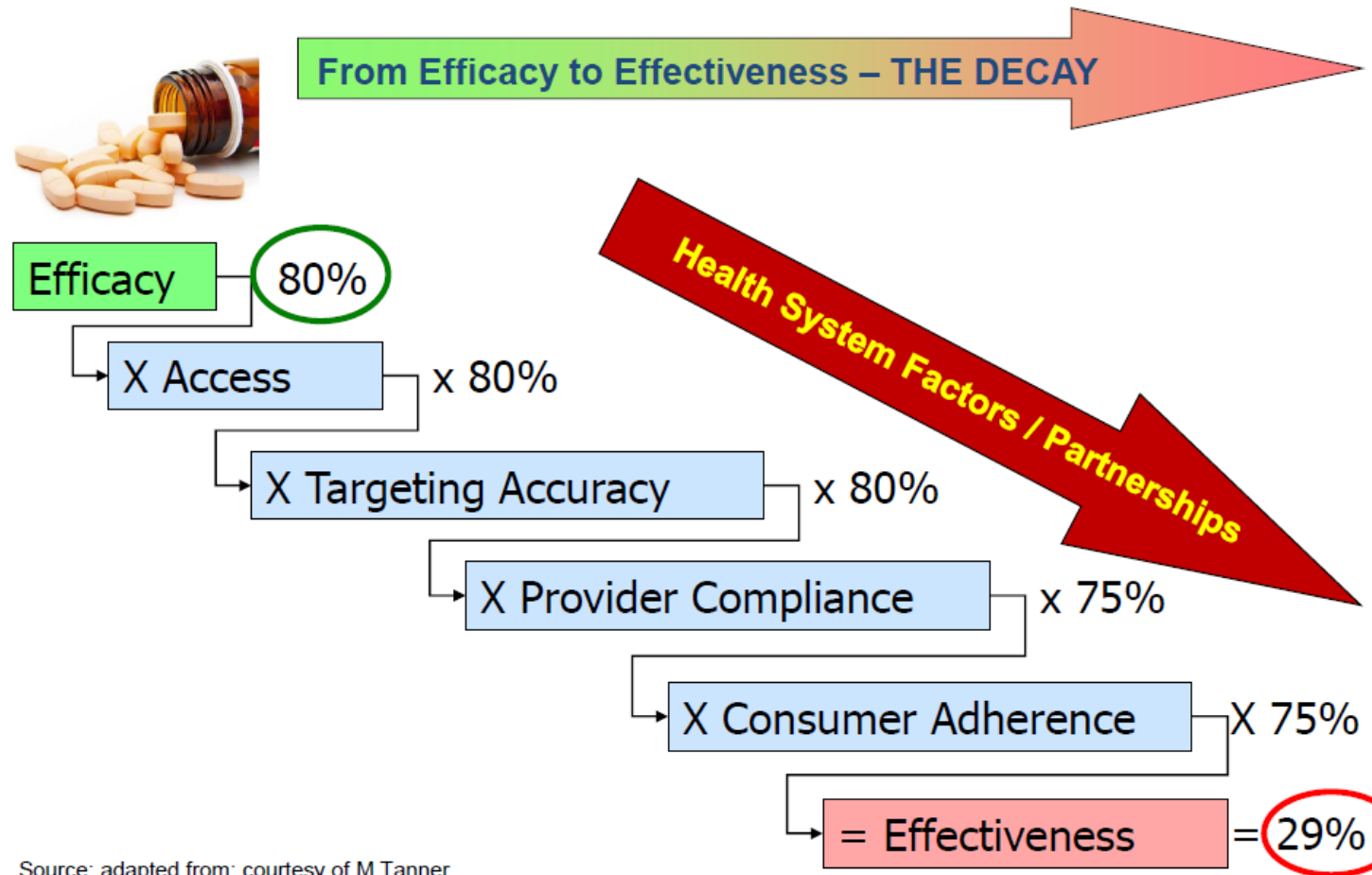
Un système de santé mal organisé et disposant de ressources insuffisantes ne rend souvent pas service aux personnes qui en dépendent

un système de santé qui fonctionne bien améliore la qualité de vie de la population.

Définition du système de santé



Pourquoi un système de santé??



Source: adapted from: courtesy of M.Tanner

Définition d'un système de santé

« Toutes les activités officielles ou non qui portent sur les services de santé mis à la disposition d'une population donnée et sur l'utilisation de ces services par la population »

OMS, 1971

Missions d'un système de santé

- Trois missions du système de santé :
 - Prévention
 - Promotion de la santé
 - Distribution des soins : ambulatoires, cliniques essentiels, soins tertiaires

Composantes

- Un système de santé s'entend: ensemble interdépendant de composantes organisées pour un but commun: améliorer la santé.
- Ses composantes: trois catégories :
 - les entrées :matières premières,
 - les processus : assurent la transformation de ces matières premières,
 - les sorties: flux de prestations fournies par le système, comme produits de son activité.

Approche systémique

QE!!

Cadre conceptuel du système de santé proposé par l'OMS

Éléments constitutifs du système



ACCÈS
COUVERTURE

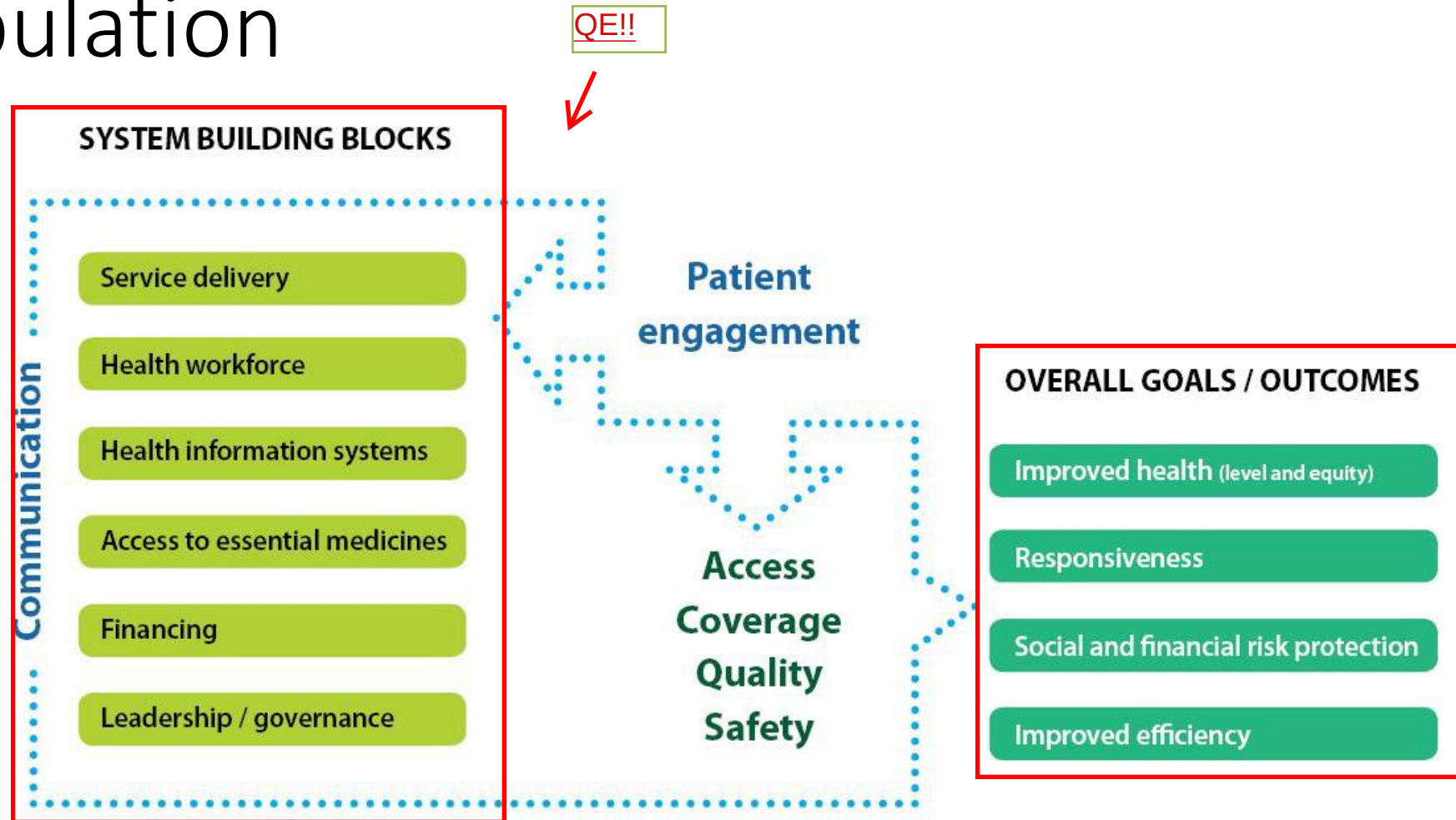


QUALITÉ
SÉCURITÉ

Objectifs d'ensemble / résultats

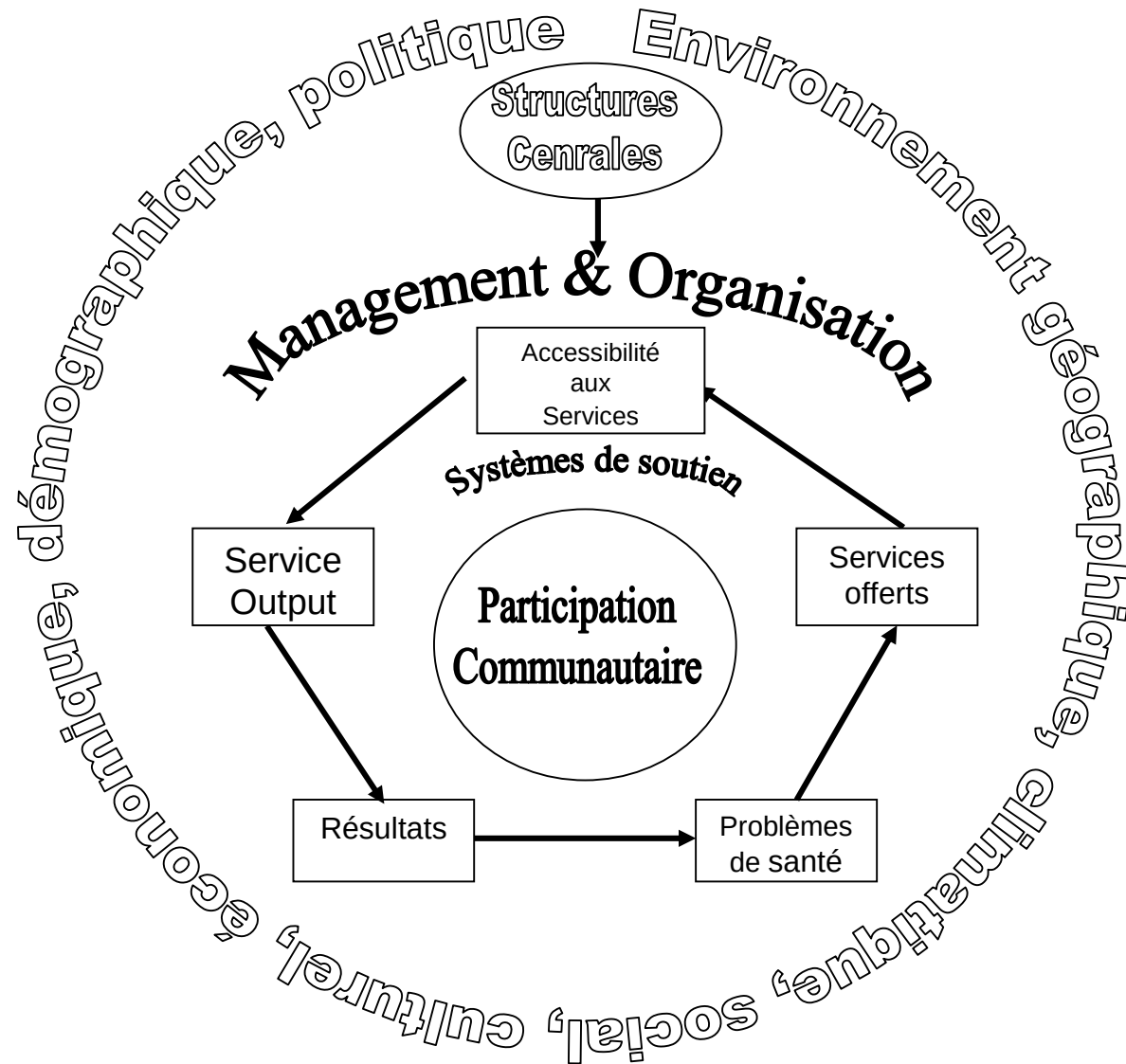


Le rôle central de la communication et de la population



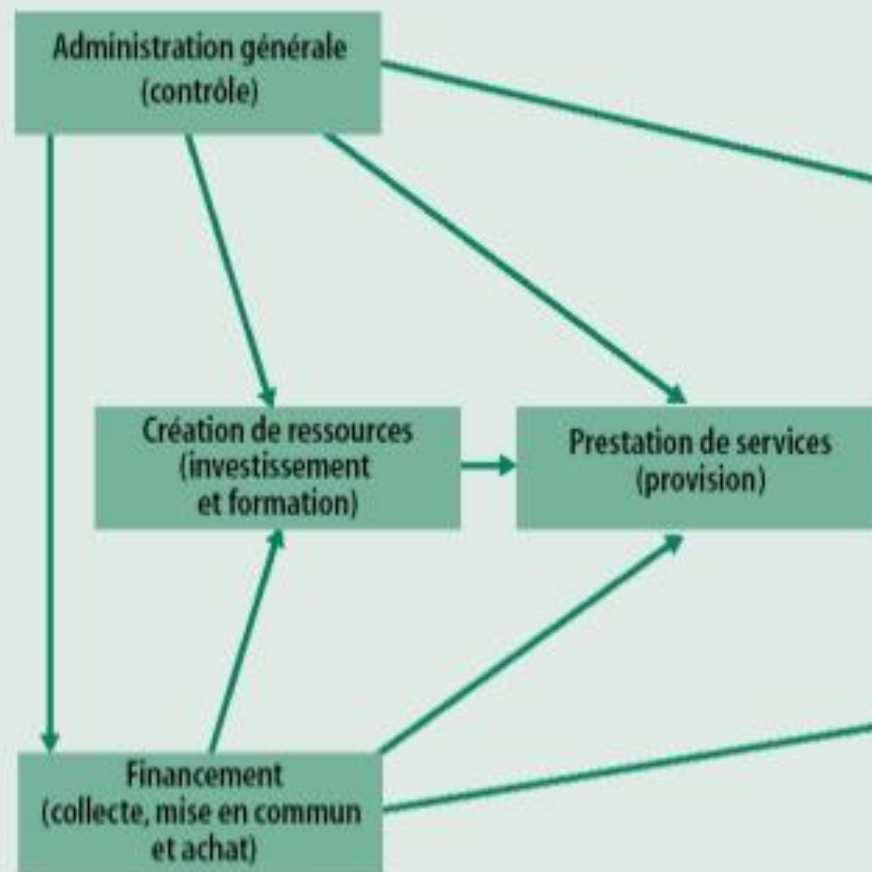
Source: Lazarus and France. A new era for the WHO health system building blocks? 2014

Un modèle global de Système de Santé



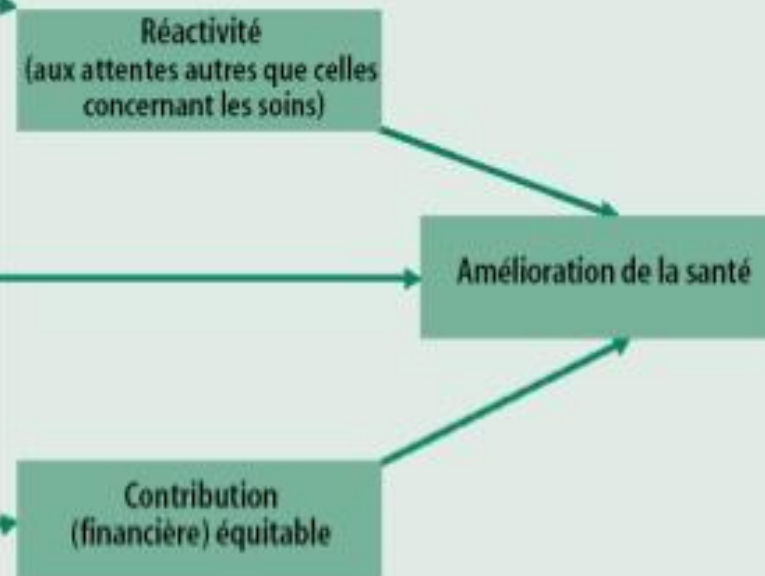
Objectifs/fonctions d'un système de santé (OMS, 2000)

Fonctions du système



Objectifs du système

QE!!



Le cas de l'Allemagne: Bismarckien ou assurantiel

- Introduction : contexte historique :
 - 1883, système Bismarckien : qui travaille est assuré
 - 1977-1990 : Allemagne: le 1er pays de l'UE à mettre une réforme visant à maîtriser les dépenses de santé

En Allemagne : le financement

- La technique de l'assurance repose sur 3 principes :
 - Son caractère obligatoire
 - Un niveau de contribution proportionnel au salaire et non au risque
 - Une charge financière répartie entre les assurés et employeurs avec possibilité de subventions de l'État
- Le type de protection sociale est un système fondé sur les assurances sociales :
 - Elles sont regroupées par régions ou par corps professionnels
 - Elles sont dirigées par autogouvernement (les dirigeants sont élus par les membres), avec une gestion paritaire par les employés et les employeurs.

En Allemagne : l'évolution

- Une maîtrise des coûts et un contrôle des déficits
- Une augmentation de la part à la charge de l'assuré
- Une suppression de certaines prestations des caisses publiques d'où un recours aux assurances privées
- Une concurrence entre les hôpitaux et entre les caisses

Les modèles Beverdgiens

- Lord Beveridge, père fondateur du système britannique,
- ***Gestion par l'État et financement par l'impôt.***
- Principes d'universalité et d'égalité,
 - Accès gratuit
 - aux services de soins pour les résidents,
 - des hôpitaux publics et des professionnels de santé pour la plupart des fonctionnaires salariés.

Financement du système de santé britannique

- Planifié et administré au niveau central
- Dépenses sociales : 20,70% du PIB
 - Dont 37,5% pour la santé
- Le financement des dépenses de santé
 - public :88% (essentiellement de l'impôt)
 - privées:12%
 - ticket modérateur (70%) et assurances complémentaires (30%)

Fonctionnement du système de santé britannique

- La couverture maladie est universelle.
 - Les soins sont gratuits pour toute personne en exprimant le besoin ou la nécessité.
- une participation financière forfaitaire du patient par ordonnance
- Le malade a un choix limité
 - attente longue pour toute prestation

Le système mixte

- Les régimes mixtes d'Europe du Sud sont marqués par la combinaison d'éléments divers, inspirés des différents systèmes :
- mélange dans le financement d'impôts et de cotisations, d'organismes publics et privés ou d'assurances sociales et de services de santé directement fournis par l'État

Cas de l'Espagne

- Financement exclusivement par les cotisations sociales et par l'impôt
- Couverture universelle, cotisation obligatoire, égalité d'accès, garantie d'un financement public, gestion publique des services de santé
- Vaste décentralisation vers les communautés autonomes (régions)
 - Chaque communauté adopte sa réglementation
 - L'état définit les normes de base,

La France

- Les régimes d'assurance maladie obligatoire de base caractérisés par:
 - L'obligation d'adhésion et de cotisation et reposent sur une solidarité large,
- Les régimes complémentaires (mutuelles..)
 - Solidarité restreinte: couvrir la part des dépenses non prise en charge par le régime de base
- Les financeurs publics (Etat)
 - dépenses de prévention, recherche et formation
- Les ménages
- Les déficits annuels de la sécurité sociale :
 - 2014: 11,7 milliards
 - 2022: 19,6 Milliard Euros

Les régimes libéraux

Les Etats-Unis

Les régimes libéraux

- Au contraire des systèmes nationaux de santé, les régimes libéraux se caractérisent par l'absence de protection sociale publique universelle et obligatoire financée par la solidarité.
- Ils reposent sur l'assurance privée, même si des programmes publics d'assurance existent pour certaines catégories
- Caractéristique:
 - pas de couverture généralisée de la population.
 - pas de financement public généralisé.
 - liberté de l'offre et demande.

La réforme Obama 2009

- Discours devant le congrès objectifs :
 - Rejet d'une assurance publique obligatoire et universelle,
 - Exclusion de l'option d'une libéralisation complète du marché de l'assurance,
 - La réforme doit améliorer la situation des américains qui disposent déjà d'une assurance,
 - Permettre aux américains qui n'ont pas d'assurance de s'en procurer une à un prix raisonnable,
 - Obligation pour chacun de s'assurer.

Les programmes publics :

- Medicare
 - pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes handicapées
 - assurance hospitalisation obligatoire qui ne couvre que les dépenses d'hospitalisation pour les soins aigus et les soins de suite,
 - Assurance supplémentaire, optionnelle et payante qui couvre les honoraires des professionnels
- Medicaid
 - pour les familles pauvres (revenu familial <133% du seuil de pauvreté)
 - PEC d'hospitalisation, consultations, analyses, radiologie, soins de long séjour et services de médecine préventive pour <21 ans
- Il existe un autre programme important: le SCHIP (State Children's Health Insurance Program).
 - C'est une assurance destinée aux enfants vivant dans des ménages ne relevant pas de Medicaid et disposant de revenus inférieurs à 200% du seuil de pauvreté fédéral (33 200\$ par an pour trois personnes).
 - Il est financé en grande partie par l'Etat fédéral mais aussi par les Etats fédérés.
- Plus de 15% de la population, soit près de 47 millions de personnes, n'est pas couverte
 - La part des adultes non assurés est très variable selon les Etats : 10,4% dans l'Iowa, 24% en Floride et 27% au Texas.
 - 9 millions d'enfants ne sont pas assurés (les trois-quarts sont éligibles à Medicaid ou SCHIP), 46% sont d'origine hispanique.
 - La part des enfants non assurés varie selon les Etats : 20,4% des enfants au Texas contre 5,6% au Massachusetts
- Les immigrés et leurs enfants entrés depuis moins de 5 ans aux Etats-Unis ne sont pas éligibles aux programmes Medicaid et SCHIP

Les assurances liées à l'emploi : Managed Care Organizations

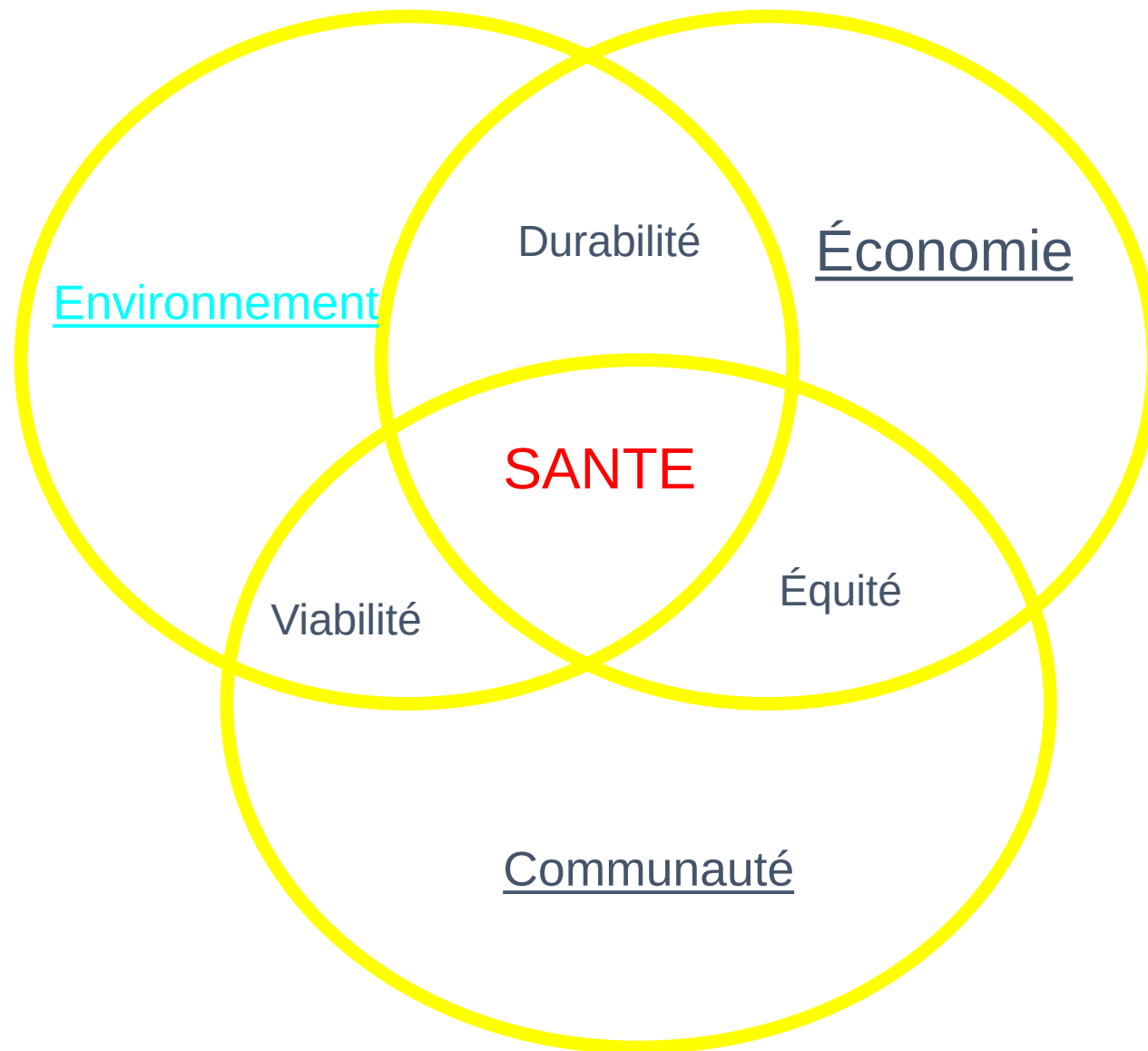
- Les MCO ont les soins clés en main : les médecins de ville et les hôpitaux sont sur des listes fixées par l'assurance.
- Les patients sont interrogés : les MCO sont orientées vers les économies (réduction du temps passé avec le médecin, difficultés pour accéder au spécialiste...)
- Les points positifs des MCO sont :
 - des politiques de prévention mises en place,
 - des services d'éducation à la santé (programmes d'exercice physique pour les personnes obèses et en surpoids)
 - des programmes de « disease management » (coordination de l'ensemble des soins pour des pathologies chroniques et coûteuses comme le diabète ou le cancer)

Financement

- Le financement public
 - 45% des dépenses de santé: contributions de l'État fédéral et des États fédéré (Medicare) et (Medicaid)
- L'assurance maladie privée liée à l'emploi
 - mode de couverture le plus répandu (2/3 des américains de moins de 65 ans)
- L'assurance maladie privée à titre individuel

Répartition de la population concernant la couverture maladie

- Les plus de 65 ans
 - couverts par Medicare
- Les moins de 65 ans
 - 2/3 des personnes sont couvertes par MCO
 - autre modalité (assurance individuelle, ...)
 - des individus ne bénéficient pas d'AM.
- La population non couverte
 - Diminution de la population non couverte depuis l'entrée en vigueur de la loi Obama Care en 2014
 - 26 M personnes en 2022 contre 50 millions en 2009



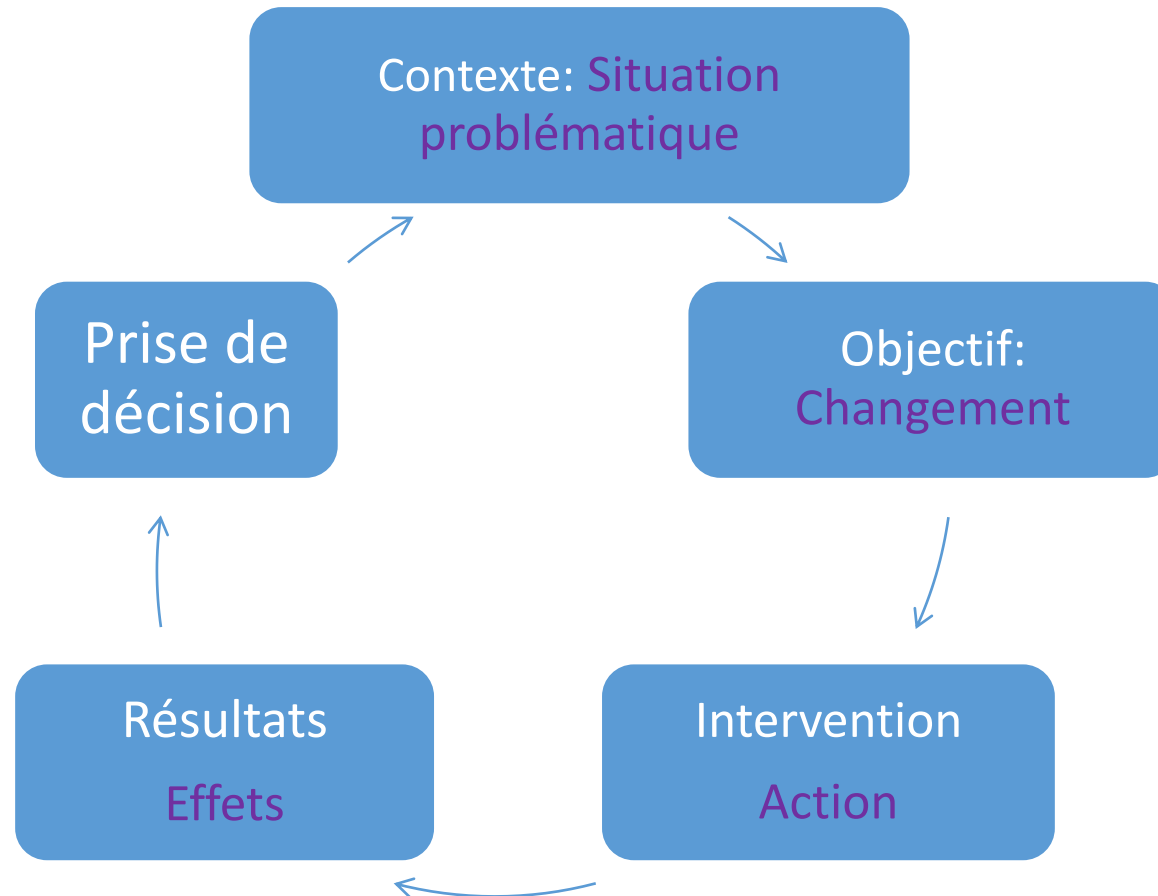
Intervention en santé: définition

- Une intervention en santé publique:
 - « un ensemble d'actions organisées
 - dans un contexte spécifique à un moment spécifique
 - pour produire des biens ou des services dans le but
 - de modifier une situation problématique »

Champagne *et al*
- « Système organisé d'actions visant, dans un environnement donné, à modifier le cours prévisible d'un phénomène pour corriger une situation problématique » Contandriopoulos *et al*

QE!!

Cycle d'une intervention de santé



Intervention en santé: définition

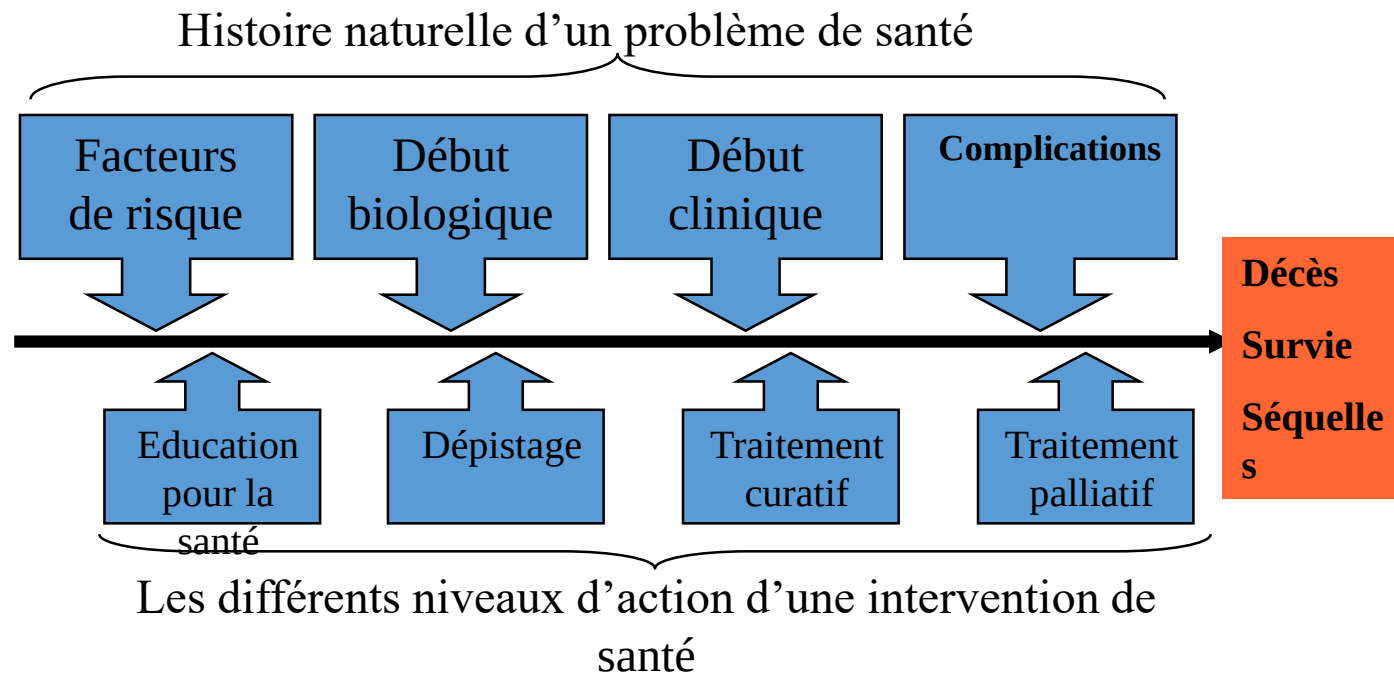
- Lien avec la démarche d'aide à la décision
 - Quel est le problème à résoudre?
 - Quelle est l'intervention proposée?
 - Quel serait son effet?
 - Pérennisation
 - Amélioration
 - Changement

Buts d'une intervention

- Les intervention en santé Publique
 - Buts
 - Education pour la santé
 - Action sur les comportement: changement des attitudes
 - Prévention
 - Réduire la fréquence et gravité des problème de santé
 - Dépistage
 - Agir sur le processus évolutif d'un problème de santé
 - Diagnostic
 - Mettre en évidence une maladie
 - Thérapeutique
 - Prise en charge
 - Réadaptation

Niveau d'action d'une intervention en santé

QE!!



Les intervention en santé Publique

- Niveau de complexité
 - Technique
 - Méthodes pour faire quelque chose
 - Pratique
 - Ensemble d'activités pour appliquer une technique
 - Programme
 - Organisation coordonnée de pratiques
 - Politique
 - Stratégie formelle d'action réglementées ou recommandée

Exemple de techniques

- Méthodes pour faire quelque chose
 - Prévention
 - Injection du vaccin contre l'hépatite B
 - Dépistage
 - Mammographie pour détecter un cancer du sein
 - Diagnostic
 - IRM : repérer une image spécifique d'un type de lésion
 - Thérapeutique
 - Antiagrégant plaquettaire Réadaptation
 - Attelle articulaire pour le genou

Exemples de pratique

- Ensemble d'activités pour appliquer une technique
 - Education pour la santé
 - Information sur les effets du tabac
 - Dépistage
 - Prise de la tension artérielle en Médecine générale
 - Diagnostic
 - IRM cérébral après un traumatisme crânien
 - Thérapeutique
 - Antiagrégant plaquettaire après un AVC
 - Réadaptation
 - Séances de rééducation en parallèle avec un traitement anti arthrosique pour arthrose du genou

Un programme de santé

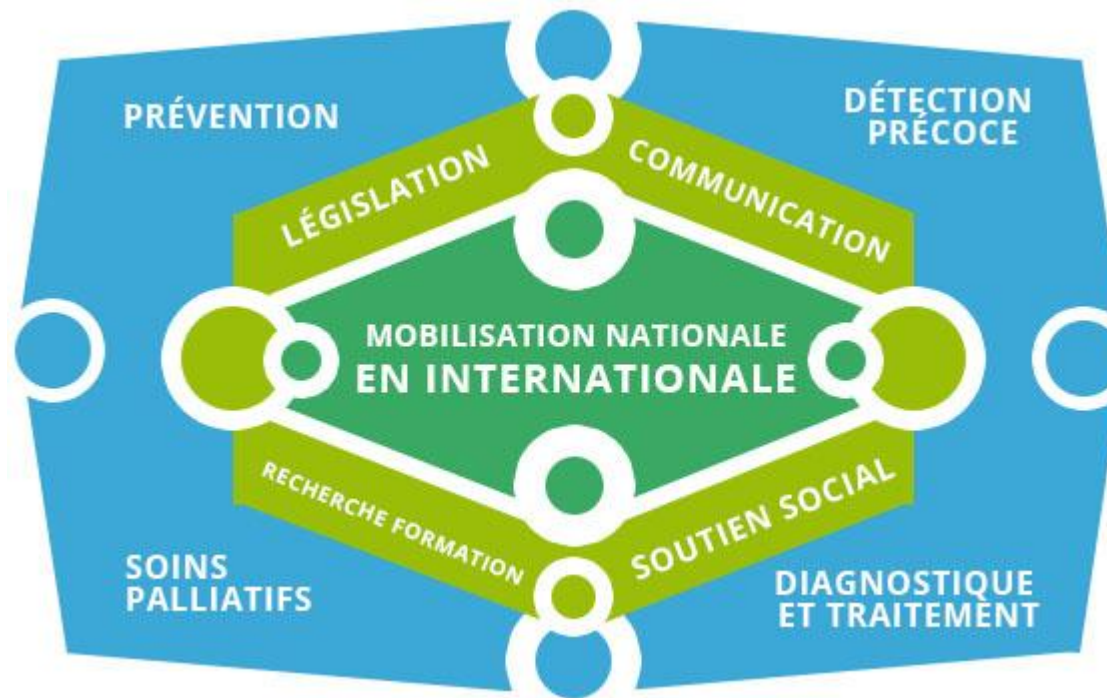
- Ensemble d'activités coordonnés, de mesures uniques, de processus et/ou services qui visent à aboutir à un BUT commun.

Un plan de santé publique

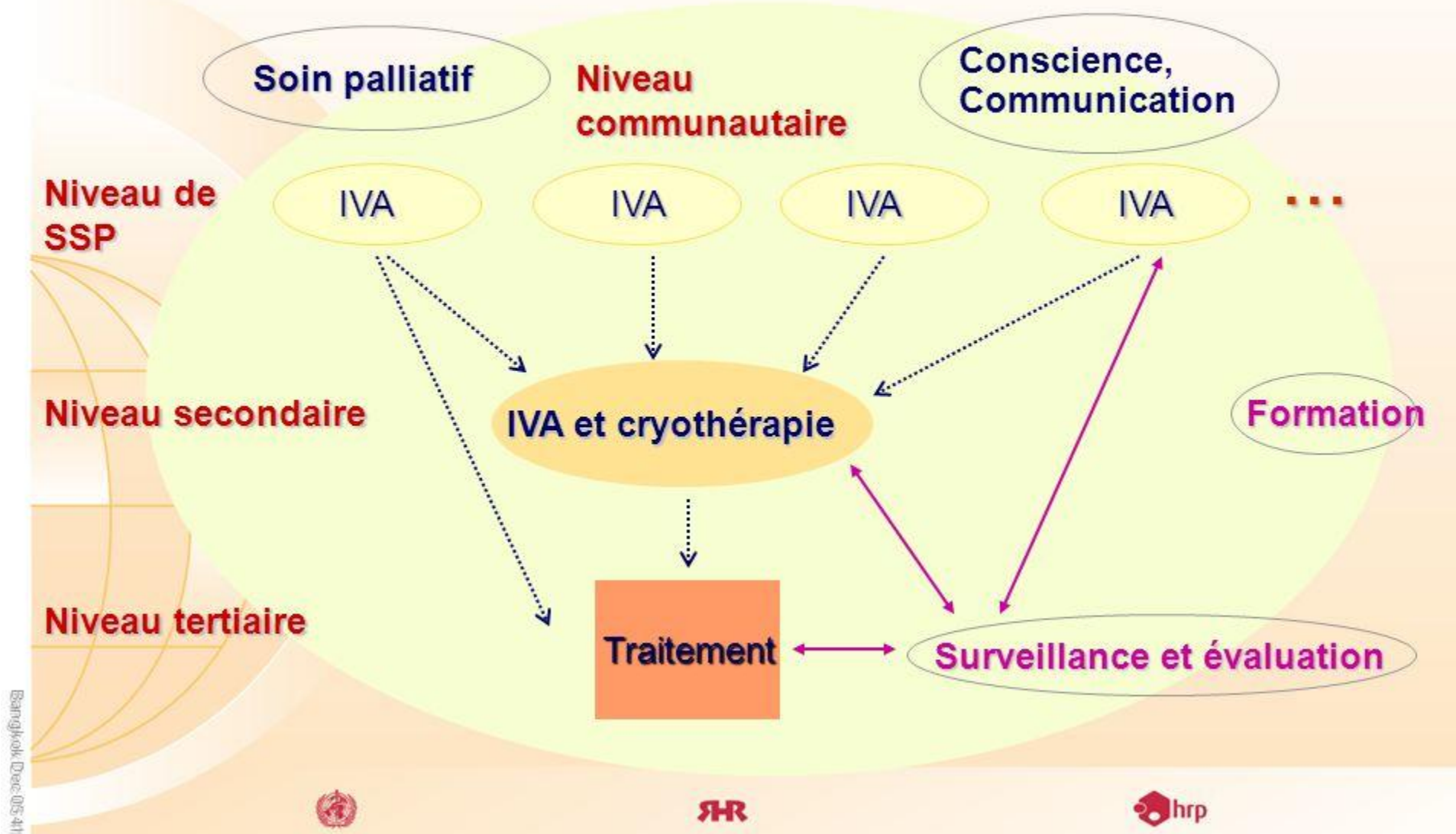
- Ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution d'un programme et de se compose d'une série d'actions
 - Ensemble de dispositions arrêtées en vue de l'exécution d'un programme et de se compose d'une série d'actions
 - Choix stratégiques en retenant certains types d'intervention et hiérarchisant priorités

Un plan de santé publique

- Plan national de prévention de lutte contre le cancer au Maroc 2010 – 2019



Renforcer les programmes de prévention du cancer du col



World Health Organization

CHP Department of Chronic Diseases and Health Promotion



Reproductive Health and Research



UNDP • UNFPA • WHO • World Bank
Special Programme of Research, Development
and Research Training in Human Reproduction

Exemple de programmes

- Organisation coordonnée de pratiques
 - Prévention
 - Compagne de sensibilisation au risques sanitaire liés au tabac
 - Dépistage
 - Détection précoce du cancer du sein par la mammographie
 - Diagnostic
 - Diagnostic positif du cancer du col par la biopsie
 - Thérapeutique
 - Réseau intégré des soins d'urgences médicales

Projet de santé

- Projet:
 - Ensemble d'activités, de prestations ou d'interventions coordonnées et conçues pour atteindre un même BUT prédéfini.
 - Il est limité en termes de temps, d'étendue et de budget.
 - Exemple: Projet ETTAM: étude tabagisme tuberculose au Maroc

Politique de santé

- Les politiques de santé comprennent l'ensemble des choix stratégiques des pouvoirs publics pour améliorer l'état de santé des populations dont ils ont la responsabilité.
- Il s'agit de :
 - déterminer les aires et champs d'intervention
 - fixer les objectifs et choisir les priorités
 - programmer les moyens engagés

Exemples de politiques

- Stratégie formelle d'action réglementées ou recommandée
 - Prévention
 - Priorisation de la vaccination comme prévention des maladies cible
 - Dépistage
 - Obligation du dépistage du diabète gestationnel
 - Diagnostic
 - Définition du nombre de scanners par habitants
 - Thérapeutique
 - Recommandation de l'OMS pour le traitement de la tuberculose
 - Réadaptation
 - Agrément des kinésithérapeutes comme professionnel de santé